内科＋外科 类风湿关节炎 ★★☆（0~2题）

- 病理
  - 慢性非特异增生性炎（外 2007）
  - 病变始于滑膜（外 2008）
- 青年女性多见（内 2022、2025，外 2007、2021）
  - 明显晨僵（可≥1小时，休息后加重）
  - 关节痛（最早）、肿胀
    - 腕、掌指、近端指间关节至少 1 个肿胀（内 2016）
    - 多发（≥ 3 个关节区）对称
  - 晚期关节畸形：天鹅颈样 / 纽扣花样 / 手关节尺侧偏斜“三不”（内 2011）
    - 不可逆
    - 与病情活动性无关
    - 不属于类风湿诊断标准（内 2015，外 2021）
  - 关节外表现
    - 类风湿结节（皮肤特异表现）：对称、无痛
    - Felty 综合征：脾大 + 全血细胞↓
      - 活动期血小板可↑（内 2018）
- 自身抗体（内 2008、2019、2022）
  - RF（IgM 为主）
    - 80% 阳性（外 2007）
  - 抗瓜氨酸化蛋白抗体
    - 抗环瓜氨酸肽抗体 CCP（敏感性和特异性都高）
    - 抗突变型瓜氨酸化波形蛋白、抗聚丝蛋白、抗核周因子、抗角蛋白抗体“和瓜瓜一起周游每个角落”
- 手指及腕关节 X 线分期“种树摘虫子”（内 2025）
  - Ⅰ：关节周围软组织肿胀、骨质疏松
  - Ⅱ：关节间隙变窄
  - Ⅲ：关节面出现虫噬样骨质破坏
  - Ⅳ：关节半脱位、纤维性或骨性强直
- 同服
  - NSAIDs（首选选择性 COX-2 抑制剂如塞来昔布、美洛昔康）或糖皮质激素
  - DMARDs（首选甲氨蝶呤，内 2012）
    - 控制病情进展